成人咳嗽

知识类别：症状与就医指引
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/lung-and-airway-disorders/symptoms-of-lung-disorders/cough-in-adults
获取日期：2026-10-17

以下为逐字转载的原文内容：

成人咳嗽
病因 |
评估 |
治疗 |
关键点 |
多媒体 |
咳嗽是一种突然的，将气体排除的运动。它是人们就医最常见的原因之一。咳嗽能保护肺脏免受吸入粉尘的影响。人们可能会故意（自主性）或自发（非自主性）的咳嗽。（另见 儿童咳嗽 。）
咳嗽会有多种变化。咳嗽可以为干性的（非产出性）或是产出性的，咯出血液或唾液（也称为痰液）。痰液是由黏液、碎片和肺部脱落细胞等组成的混合物。痰可以是无色透明的、黄色的、绿色的或者是夹杂血液的。
咳嗽非常剧烈的患者可能会出现肋骨肌肉或软骨紧张，导致胸痛，特别是当他们吸气、活动或再次咳嗽时。咳嗽非常令人讨厌，可以影响睡眠。但如果咳嗽缓慢进展超过十年时间，如同吸烟者一样，平时可能对咳嗽症状不会引起重视。
咳嗽的病因
气道受刺激时常会出现咳嗽。引起咳嗽的可能原因取决于咳嗽的持续时间是少于 3 周（急性）、3 至 8 周（亚急性）还是 8 周或更长时间（慢性）。
常见原因
对于 急性咳嗽， 最常见的原因是：
上呼吸道感染 (URI)，包括 急性支气管炎
上呼吸道感染 (URI)，包括 急性支气管炎
鼻粘膜的炎症和肿胀（ 鼻炎 ）或鼻窦的炎症和肿胀（鼻窦炎），导致后鼻滴涕（鼻腔分泌物流至咽喉或咽部）
鼻粘膜的炎症和肿胀（ 鼻炎 ）或鼻窦的炎症和肿胀（鼻窦炎），导致后鼻滴涕（鼻腔分泌物流至咽喉或咽部）
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
肺炎
肺炎
百日咳
百日咳
心力衰竭 发作
心力衰竭 发作
对于 亚急性咳嗽， 最常见的原因是：

呼吸道感染消退后气道过度敏感
呼吸道感染消退后气道过度敏感
对于 慢性咳嗽， 最常见的原因是：
鼻粘膜的炎症和肿胀（ 鼻炎 ）或鼻窦的炎症和肿胀（鼻窦炎），导致后鼻滴涕（鼻腔分泌物流至咽喉或咽部）
鼻粘膜的炎症和肿胀（ 鼻炎 ）或鼻窦的炎症和肿胀（鼻窦炎），导致后鼻滴涕（鼻腔分泌物流至咽喉或咽部）
胃食管反流
胃食管反流
哮喘
哮喘
慢性支气管炎
慢性支气管炎
慢性阻塞性肺疾 病（COPD）
慢性阻塞性肺疾 病（COPD）
使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂，这类抑制剂是降压药物
使用血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂，这类抑制剂是降压药物
咳嗽持续不愈，且原因不明
咳嗽持续不愈，且原因不明
不常见原因
对于 急性咳嗽， 较少见的原因包括：
血凝块堵在肺部（ 肺栓塞 ）
血凝块堵在肺部（ 肺栓塞 ）
吸入异物（如一块食物）（误吸）
吸入异物（如一块食物）（误吸）
但是，不小心吸入东西的患者通常知道他们为什么咳嗽，并且会告诉他们的医生，除非他们有痴呆症、卒中或导致记忆、认知或沟通困难的其他疾病。
对于 慢性咳嗽， 较少见的原因包括：
肺癌
肺癌
结核病
结核病
肺部真菌感染
肺部真菌感染
痴呆或卒中患者通常有 吞咽困难 。因此，他们可能会将少量食物或饮料、唾液或胃内容物误吸入他们的气管（气管）。他们的照顾者不知情的情况下，这些人可能反复吸少量这些物质，可能会发展为慢性咳嗽。
哮喘 可能引起咳嗽。在极少数情况下，哮喘的主要症状是咳嗽而不是喘息。这种类型的哮喘被称为咳嗽变异型哮喘。
儿童咳嗽 的原因与成人相似，但 哮喘 在儿童中更为常见。异物吸入在成人中并不常见，除非是有发育障碍、痴呆或吞咽功能障碍的患者，但在儿童中则更为常见。
其他原因包括心因性咳嗽，这是一种没有明显医学病因的咳嗽，被认为是心理压力引起的。即使存在已知的医学病因，有些人咳嗽也可能是出现心理因素（即，他们咳嗽是因为他们感到不得不咳嗽）。
咳嗽的评估

并不是每一个咳嗽者都需要立即由医生检查。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
某些症状和特征需引起人们的关注。它们包括：
气短
气短
咳血
咳血
体重减轻
体重减轻
发热时间超过1周
发热时间超过1周
结核病 的危险因素，如接触到结核病、存在 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染 或是使用类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）或其他会抑制免疫系统的药物
结核病 的危险因素，如接触到结核病、存在 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染 或是使用类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）或其他会抑制免疫系统的药物
有 HIV 感染的危险因素，如高风险性活动或注射非法药品
有 HIV 感染的危险因素，如高风险性活动或注射非法药品
何时就医
存在警示体征应该立即就医，只存在体重减轻一个警示体征者除外。但是，短暂的推迟也不会造成损害。可能已经吸入异物的人也应该马上去看医生。
急性咳嗽但没有警示体征的人，可以等待几天，看咳嗽是否停止或变得不那么严重，特别是如果他们也有鼻塞、喉咙痛，这表明其原因可能是上呼吸道感染 (URI)。
有慢性咳嗽、但没有警示体征的人在某些情况下应看医生，但短暂的推迟也不会造成损害。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史询问和体格检查中的发现通常提示咳嗽的病因和可能需要进行的检查（见表 咳嗽的某些原因和特点 ）。
一些明显的发现是不太有助于作出诊断，因为它们可以发生在很多引起咳嗽的疾病中。例如，无论痰为黄色或绿色或厚或薄，并不利于细菌感染和其他可能的原因的区分。喘息可能发生在 支气管炎 、哮喘 或是其他疾病中。咳血也可能是其他疾病的症状，包括 支气管炎 、 结核病 和 肺癌 。
成人咳嗽的某些原因和特点
成人咳嗽的某些原因和特点
病因
病因
临床特征*
临床特征*
检查
检查
急性（持续时间少于3周）
急性（持续时间少于3周）
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
喘息，气促，以及张口呼吸 患者往往会在咳嗽时产生痰液 已有慢性阻塞性肺疾病的患者
喘息，气促，以及张口呼吸

患者往往会在咳嗽时产生痰液
已有慢性阻塞性肺疾病的患者
通常只进行医生检查
通常只进行医生检查
异物
异物
通常患有会影响沟通、吞咽功能或两者兼具的人或儿童突然开始咳嗽 无上呼吸道感染症状 其他感觉良好的人
通常患有会影响沟通、吞咽功能或两者兼具的人或儿童突然开始咳嗽
无上呼吸道感染症状
其他感觉良好的人
胸部 X 线检查 支气管镜
胸部 X 线检查
支气管镜
心脏衰竭
心脏衰竭
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现 一般通过听诊器可闻及肺部积水声 通常有腿部肿胀（水肿）
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现
一般通过听诊器可闻及肺部积水声
通常有腿部肿胀（水肿）
胸部 X 线检查 有时通过血液检查去测定脑利尿钠肽（BNP），脑利尿钠肽是一种心脏收紧时产生的物质 有时进行超声心动图检查
胸部 X 线检查
有时通过血液检查去测定脑利尿钠肽（BNP），脑利尿钠肽是一种心脏收紧时产生的物质
有时进行超声心动图检查
肺炎
肺炎
发热是一种生病的感觉，有痰的咳嗽（产出性咳嗽） 呼吸困难，深呼吸时突发的一过性的剧烈胸痛 通过听诊器听到某些异常呼吸音 有时血氧饱和度低
发热是一种生病的感觉，有痰的咳嗽（产出性咳嗽）
呼吸困难，深呼吸时突发的一过性的剧烈胸痛
通过听诊器听到某些异常呼吸音
有时血氧饱和度低
胸部 X 线检查 血液、鼻腔或咽喉标本培养 检测传染性微生物的遗传物质（PCR）
胸部 X 线检查
血液、鼻腔或咽喉标本培养
检测传染性微生物的遗传物质（PCR）
后鼻滴涕（由于过敏或感染，如感冒或鼻窦炎）
后鼻滴涕（由于过敏或感染，如感冒或鼻窦炎）
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀 恶心 有时在喉咙后可见滴漏 频繁清理喉咙
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀
恶心
有时在喉咙后可见滴漏

频繁清理喉咙
通常只进行医生检查 有时应用抗组胺药、减充血剂或鼻用异丙托溴铵治疗，来判断症状是否消失 如果诊断不明确，有时会进行鼻窦计算机断层扫描（CT）
通常只进行医生检查
有时应用抗组胺药、减充血剂或鼻用异丙托溴铵治疗，来判断症状是否消失
如果诊断不明确，有时会进行鼻窦计算机断层扫描（CT）
肺栓塞 （肺动脉突然受阻，通常是血栓引起）
肺栓塞 （肺动脉突然受阻，通常是血栓引起）
突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化 气短 心率快和呼吸频率加快 有时血氧饱和度低 常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有 雌激素 的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史
突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化
气短
心率快和呼吸频率加快
有时血氧饱和度低
常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有 雌激素 的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史
特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影
特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影
上呼吸道感染，包括 急性支气管炎
上呼吸道感染，包括 急性支气管炎
一个流涕、鼻塞并有红色黏膜（划分鼻部的组织）的鼻腔 喉咙痛和不舒服（不适）
一个流涕、鼻塞并有红色黏膜（划分鼻部的组织）的鼻腔
喉咙痛和不舒服（不适）
通常只进行医生检查
通常只进行医生检查
亚急性（持续 3 至 8 周）
亚急性（持续 3 至 8 周）
呼吸道感染治愈后仍然存在的气道刺激
呼吸道感染治愈后仍然存在的气道刺激
呼吸道感染后立刻发生的干咳、非排痰性咳嗽 无鼻塞或喉咙痛
呼吸道感染后立刻发生的干咳、非排痰性咳嗽
无鼻塞或喉咙痛
有时只有通过医生的检查 有时进行胸部 X 线检查
有时只有通过医生的检查
有时进行胸部 X 线检查
慢性（持续 8 周或更久）
慢性（持续 8 周或更久）
血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂
血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂
干咳，持续性咳嗽，常发生在夜间 应用一种血管紧张素转化酶抑制剂（咳嗽可能会在用药几天或几个月后开始出现）
干咳，持续性咳嗽，常发生在夜间
应用一种血管紧张素转化酶抑制剂（咳嗽可能会在用药几天或几个月后开始出现）

停止使用血管紧张素转化酶抑制剂来判断症状是否消失
停止使用血管紧张素转化酶抑制剂来判断症状是否消失
误吸
误吸
一种湿性咳嗽，在进食或进水后可见吞咽困难，或两者均存在 哮鸣 在患有卒中或者其他导致沟通困难的疾病（如痴呆症），特别是在有慢性咳嗽的患者中
一种湿性咳嗽，在进食或进水后可见吞咽困难，或两者均存在
哮鸣
在患有卒中或者其他导致沟通困难的疾病（如痴呆症），特别是在有慢性咳嗽的患者中
胸部 X 线检查 有时会进行吞咽功能的X射线检查（改良钡剂咽造影术）或插入软管观察吞咽情况（纤维内镜吞咽评估）。 支气管镜
胸部 X 线检查
有时会进行吞咽功能的X射线检查（改良钡剂咽造影术）或插入软管观察吞咽情况（纤维内镜吞咽评估）。
支气管镜
哮喘 （包括咳嗽变异性哮喘）
哮喘 （包括咳嗽变异性哮喘）
发生在多种触发因素之后的咳嗽，如接触花粉或其他过敏原、寒冷、运动或感染 可能会喘息和呼吸困难
发生在多种触发因素之后的咳嗽，如接触花粉或其他过敏原、寒冷、运动或感染
可能会喘息和呼吸困难
评估肺功能是否良好的检查（ 肺功能检查 ） 有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物），如沙丁胺醇，来判断症状是否消失
评估肺功能是否良好的检查（ 肺功能检查 ）
有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物），如沙丁胺醇，来判断症状是否消失
慢性支气管炎 （常见于吸烟者或长期暴露于空气污染、灰尘和烟雾中的人群）
慢性支气管炎 （常见于吸烟者或长期暴露于空气污染、灰尘和烟雾中的人群）
在连续两年中每年有三个月每个月大多数日子都出现排痰性咳嗽 经常清理喉咙或呼吸困难 无鼻塞或喉咙痛
在连续两年中每年有三个月每个月大多数日子都出现排痰性咳嗽
经常清理喉咙或呼吸困难
无鼻塞或喉咙痛
肺功能检查
肺功能检查
胃食管反流
胃食管反流
胸部（胃灼痛）或腹部灼痛，并且在吃特定的食物时、休息时或平躺时加重 感到有酸味，尤其在睡醒时 口臭 声音嘶哑 哮鸣 半夜或清晨咳嗽 有时除咳嗽外无其他症状
胸部（胃灼痛）或腹部灼痛，并且在吃特定的食物时、休息时或平躺时加重
感到有酸味，尤其在睡醒时
口臭
声音嘶哑
哮鸣
半夜或清晨咳嗽

有时除咳嗽外无其他症状
有时只有通过医生的检查 有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体（H2）阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失 有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查） 有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）
有时只有通过医生的检查
有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体（H2）阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失
有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查）
有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）
间质性肺疾病
间质性肺疾病
逐渐发作的呼吸短促 干咳 通过听诊器听到某些异常呼吸音 既往暴露于某些药物或职业暴露 有时有此疾病的家族史
逐渐发作的呼吸短促
干咳
通过听诊器听到某些异常呼吸音
既往暴露于某些药物或职业暴露
有时有此疾病的家族史
胸部 X 线检查 胸部 CT 扫描 肺功能测试
胸部 X 线检查
胸部 CT 扫描
肺功能测试
肺部肿瘤
肺部肿瘤
吸烟史 有时会咯血的咳嗽 慢性咳嗽的变化 体重减轻，发热和盗汗 锁骨上方淋巴结肿大、质地较硬、无痛
吸烟史
有时会咯血的咳嗽
慢性咳嗽的变化
体重减轻，发热和盗汗
锁骨上方淋巴结肿大、质地较硬、无痛
胸部 X 线检查 通常行胸部 CT 扫描 定期支气管镜检查
胸部 X 线检查
通常行胸部 CT 扫描
定期支气管镜检查
百日咳
百日咳
在一次呼气过程中反复出现快速、连续、强烈的咳嗽，随后是迅速而深长地吸气（发出呼哧声）
在一次呼气过程中反复出现快速、连续、强烈的咳嗽，随后是迅速而深长地吸气（发出呼哧声）
鼻或咽喉标本培养
鼻或咽喉标本培养
后鼻滴涕（由于过敏或鼻窦炎）
后鼻滴涕（由于过敏或鼻窦炎）
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀 有时在喉咙后可见滴漏
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀

有时在喉咙后可见滴漏
有时只有通过医生的检查 有时应用抗组胺药物或减充血剂，来判断症状是否消失 有时进行过敏检测
有时只有通过医生的检查
有时应用抗组胺药物或减充血剂，来判断症状是否消失
有时进行过敏检测
结核病 真菌感染
结核病
真菌感染
有时会咯血的咳嗽 体重减轻，发热和盗汗 和结核病患者接触 居住在或到有结核病或肺部真菌感染常见的地区旅游 存在 人类免疫缺陷病毒感染 或人类免疫缺陷病毒感染的危险因素 存在导致免疫系统功能低于健康人的疾病
有时会咯血的咳嗽
体重减轻，发热和盗汗
和结核病患者接触
居住在或到有结核病或肺部真菌感染常见的地区旅游
存在 人类免疫缺陷病毒感染 或人类免疫缺陷病毒感染的危险因素
存在导致免疫系统功能低于健康人的疾病
胸部 X 线检查 皮试，如果可能的话行痰液检查和培养 有时可行胸部 CT 扫描
胸部 X 线检查
皮试，如果可能的话行痰液检查和培养
有时可行胸部 CT 扫描
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
这些病因很罕见。
这些病因很罕见。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
这些病因很罕见。
这些病因很罕见。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。
检查
需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。
如果一个人存在警示体征，通常要进行的检查包括：
在手指上放置一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）
在手指上放置一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）
胸部 X 线检查
胸部 X 线检查
如果怀疑某人患有结核病（例如出现体重减轻），且该人存在危险因素，则会进行皮肤试验、胸部 X 线检查，有时还会进行胸部 计算机断层扫描 (CT)，并采集痰液样本进行检查和培养以确认是否存在结核病。
如果没有警示体征出现，医生往往可以依据病史和体格检查进行诊断，并且不需进行检测即可开始治

疗。对于某些患者，体格检查提示某个诊断，而进行辅助检查则是去证实诊断（见表 咳嗽的某些原因和特点 ）。
如果体格检查未提示咳嗽的原因并且也未出现警示体征，则很多医生会尝试给予患者药物，对咳嗽的三个常见原因的其中之一进行治疗：
抗组胺药/减充血剂复方制剂或类固醇或毒蕈碱拮抗剂鼻喷剂（用于后鼻滴注）
抗组胺药/减充血剂复方制剂或类固醇或毒蕈碱拮抗剂鼻喷剂（用于后鼻滴注）
质子泵抑制剂或组胺2（H2）受体阻滞剂（胃食管反流病）
质子泵抑制剂或组胺2（H2）受体阻滞剂（胃食管反流病）
吸入型类固醇或短效 β-2 激动剂支气管扩张剂（用于哮喘）
吸入型类固醇或短效 β-2 激动剂支气管扩张剂（用于哮喘）
如果这些药物缓解了咳嗽，通常就不需要进一步检查。如果仍不能缓解咳嗽，医生通常按以下顺序做一些检查，直到检查提示某种诊断：
胸部 X 线检查
胸部 X 线检查
肺功能检查 ，用于检查 哮喘 和/或 COPD
肺功能检查 ，用于检查 哮喘 和/或 COPD
CT，用于诊断鼻窦疾病的鼻窦
CT，用于诊断鼻窦疾病的鼻窦
在食管放置酸度传感器，用于检查 胃食管反流病
在食管放置酸度传感器，用于检查 胃食管反流病
如果就诊者有慢性咳嗽，医生通常会做胸部 X 线检查。如果存在咯血，医生往往会将痰标本送往实验室检查。在那里，技术人员试图通过培养样品中的细菌（痰培养），然后用显微镜来寻找样品中的癌细胞（脱落细胞学检查）。通常情况下，如果医生怀疑肺癌诊断（例如，长时间吸烟、体重减轻或有其他全身症状的中年或老年人），患者也需要做胸部 CT 扫描，有时需要支气管镜检查。
咳嗽的治疗
治疗咳嗽的最好办法是治疗基础疾病。例如，抗生素可用于 肺炎 ，含有扩张气道（支气管扩张剂）或类固醇的吸入剂，可用于 哮喘 。一般情况下，因为咳嗽在排痰和清理气道方面起着重要的作用，不应抑制咳嗽。但是，如果咳嗽严重，干扰睡眠，或具有具体的原因，可能尝试各种治疗。
对于咳嗽的患者有两种基础的治疗方法：
止咳药（镇咳疗法）可以减轻咳嗽的冲动
止咳药（镇咳疗法）可以减轻咳嗽的冲动
祛痰药，是为了使阻塞呼吸道到肺部的痰液变稀薄，使其易于咳出（但缺乏有效性的证据）
祛痰药，是为了使阻塞呼吸道到肺部的痰液变稀薄，使其易于咳出（但缺乏有效性的证据）
镇咳药物
镇咳药包括以下几种：
阿片类药物
阿片类药物
Dextromethorphan
Dextromethorphan
Benzonatate
Benzonatate
所有 阿片类药物 都能通过抑制大脑的咳嗽中枢发挥镇咳作用。可待因是最常见的阿片类镇咳药物。可待因 及其他阿片类镇咳药可引起恶心、呕吐及便秘，并具有成瘾性。阿片类镇咳药可造成患者嗜睡，尤其在合用其他降低注意力的药物时更加明显（比如饮酒、镇静剂、安眠药、抗抑郁和某些抗组胺

药）。阿片类药物非绝对安全，故医师在特殊情况下才使用它们，比如在经过其他治疗手段后依然持续咳嗽，或者是影响到睡眠。
右美沙芬 与 可待因 有关联，但从专业角度来说并不属于阿片类药物。它还可以抑制脑内的咳嗽中枢。 右美沙芬 是许多非处方（OTC）及处方咳嗽制剂的有效成分。它们无成瘾性，且很少引起嗜睡。然而，它经常被人们滥用，尤其是青少年，因为在高剂量时，它会产生兴奋效应。过量会导致幻觉，躁动，甚至有时会昏迷。对于正在服用 5-羟色胺再摄取抑制剂 治疗抑郁症的患者，药物过量特别危险。
苯佐那酯 是一种口服局部麻醉剂。它使得肺部的感应牵拉刺激的受体麻木，从而导致肺部对引发咳嗽的刺激变得不敏感。
对于一些尤其是大量咳痰的病人，应避免频繁使用镇咳药物。
祛痰药
有些医生建议使用祛痰药（有时称为粘液溶解剂），帮助松解黏液使得支气管分泌物变稀薄而方便咳出。祛痰药无法镇咳，且证据表明这些药物效果不佳。最常用的祛痰药是含有愈创甘油醚的非处方制剂。
患 囊性纤维化 时， α 链道酶（吸入性重组人脱氧核糖核酸酶 I）可用于帮助稀释因慢性呼吸道感染产生的脓性痰液。该药物似乎对慢性支气管炎患者没有效果。
此外，生理盐水或乙酰半胱氨酸雾吸（最多几天）可能有助于使浓稠的黏痰变得稀薄。
其他药物
除非由于上气道过敏导致的咳嗽，抗组胺药反而引起呼吸道干燥，对缓解咳嗽几乎没有帮助。对于其他原因如支气管炎症引起的咳嗽，抗组胺药引起的呼吸道干燥作用甚至是有害的，可使呼吸道分泌物黏稠不容易咳出。
用来缓解鼻塞的减充血剂（例如伪麻黄碱）只在缓解后鼻滴涕导致的咳嗽时方可起效。
神经调节剂（改变神经细胞[神经元]活动的化学物质），如加巴喷丁或普瑞巴林，可用于治疗对其他治疗方法无反应的慢性咳嗽。目前还有几种其他药物正在研究，用于治疗对其他疗法无反应的慢性咳嗽。
其他治疗
蒸汽吸入（例如使用蒸发器）是减轻咳嗽的一种常见方法。其他局部治疗药物，如止咳糖浆，也很受欢迎，但也没有令人信服的证据证实这些治疗是有效的。
关键点
大多数咳嗽是由轻微的呼吸道感染或鼻后滴漏引起。
大多数咳嗽是由轻微的呼吸道感染或鼻后滴漏引起。
咳嗽患者的警示体征包括呼吸短促、咯血、体重减轻、持续约一周以上的发热，以及人类免疫缺陷病毒感染或结核病的危险因素。
咳嗽患者的警示体征包括呼吸短促、咯血、体重减轻、持续约一周以上的发热，以及人类免疫缺陷病毒感染或结核病的危险因素。
医生通常可以通过收集病史和体格检查的结果进行诊断。
医生通常可以通过收集病史和体格检查的结果进行诊断。
应当仅在适当时使用药物（止咳药和祛痰药）治疗咳嗽，例如只有在严重咳嗽或医生建议时才服用止咳药。
应当仅在适当时使用药物（止咳药和祛痰药）治疗咳嗽，例如只有在严重咳嗽或医生建议时才服用止咳药。